

УДК:616-053.2-006.6-036.22 (574)

²У.Қ.Жұмашев, ²С.И.Игісінов, ²С.С. Садықов, ¹А.Н.Быковская, ¹К.А.Тохмолдаева¹Қазақтың онкология және радиология ҒЗИ,²С.Ж.Аспандияров ат. Қазақтың ұлттық медицина университеті

Қазақстандағы балалар онкологиясының 1997-2011жж аралығындығы жағдайы

Тұжырым.

Мақалада Қазақстандағы 1997-2011жылдардағы балалардың қатерлі ісіктермен аурушылығының көрсеткіштері талданып, барлық тұрғындар арасында балалардағы қатерлі ісіктердің үлесі 1,1% екендігі анықталып ($T = 0,0011\%$), балалардың қатерлі ісіктермен сырқаттанушылық динамикасы 2001жылы 6,5%-дан 2011жылы 8,5%-ға өскет байқалды. Сарапталған мәліметтер, балалардағы қатерлі ісіктердің таралуының ерекшеліктері Қазақстан аумағында климаттың-географиялық, әлеуметтік-экономикалық жағынан күрт ерекшеленетін аймақтардың болуынан, сыртқы ортаның жағымсыз факторларымен және өндірістік қалдықтар мен зиянды түтіндердің ауру балалардың ата-анасына әсер ететін канцерогендік компоненттерімен қатар гендік факторлармен байланысты деп болжауға мүмкіндік береді.

Түйінді сөздер: қатерлі ісіктер, балалар, көрсеткіштер.

Республиканың денсаулық саласында, балалар онкологиясының жағдайына көңіл бөлу әрі оны жан-жақты талдау, балалардың жас ерекшелігіне қарай онкопедиатриялық қызметті тұрақты дамыту үшін қажет. Оның үстіне бұл мәселе қолда бар ресурстық мүмкіндіктер мен аймақтарда қалыптасқан әлеуметтік-экономикалық жағдайларды ескере отырып, медициналық көмек көрсетудің оңтайлы жергілікті нұсқасының басым бағыттарын анықтап, практикалық нұсқаулар беру үшін қажет [1]. Балалардың арасында қатерлі ісіктер сирек кездесетін патология, алайда ісіктерді зерттеудің Халықаралық агенттігінің мәліметтері бойынша, балалардағы қатерлі ісіктердің жиілігі барлық онкологиялық аурулардың 2-8% құрайды [2] және соңғы уақытта қарқынды өсу үрдісі байқалуда [3,4,5,6]. Балалардағы ісіктердің пайда болуына сыртқы ортаның жағымсыз факторларымен қатар, олардың ата-анасына әсер ететін кәсіби зияндарға да байланысты [7]. Қатерлі ісіктермен сырқаттанушылық пен соның салдарынан өлім-жітім динамикасын зерттеуде, ісікке қарсы күрес үрдісін болжауда және мақсатты жоспарлауды іске асыруда, керекті жабдықтарды және обьрға қарсы дәрі-дәрмектерді, мамандарды, материалдық және қаржылық қорларды негізді түрде бөлудің ғылыми жүйесін жасау бүгінгі таңдағы кезек күттірмейтін мәселе [8]. Онкологиялық аурудың алдын алу ұстанымы, яғни тұрғындарға мамандандырылған онкологиялық жәрдем көрсетуді ұйымдастыру медицинада негізгі бағыт болып табылады. Зерттеулер мен нұсқаулардың басым көпшілігі ересектердегі обьрдың алдын алуға, олардың өмір салтын оңтайландыруға, канцерогенді факторлардың мүмкін

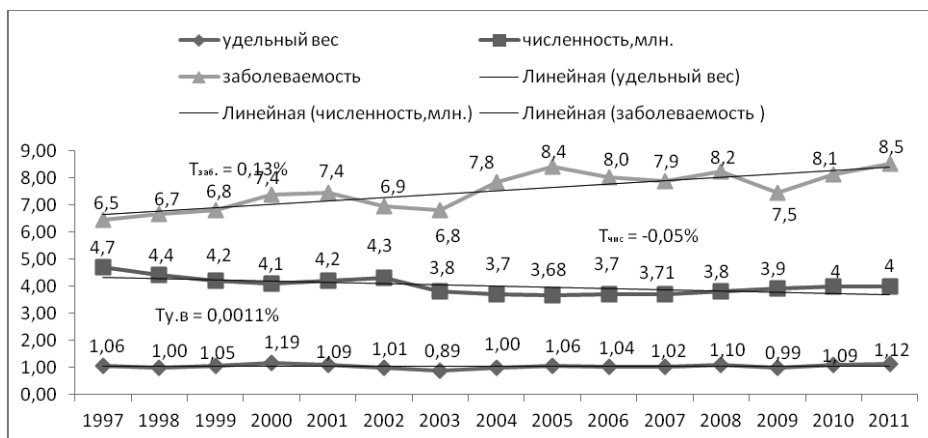
әсерлерін жоюға т.б. арналған [9]. Ал, балаларда бұл мәселе жеткіліксіз, ашылмаған және бүгінгі таңда әлі өзекті болып қалуда. Осыған байланысты, осы мақалада біз балалардағы қатерлі ісіктердің эпидемиологиялық ерекшеліктерін анықтап және Қазақстанда қатерлі ісіктері бар науқас балаларға онкопедиатриялық жәрдем көрсетуді жетілдірудің негізгі бағыттарын ғылыми түрде сараптауды мақсат еттік.

Зерттеу материалдары мен әдістері

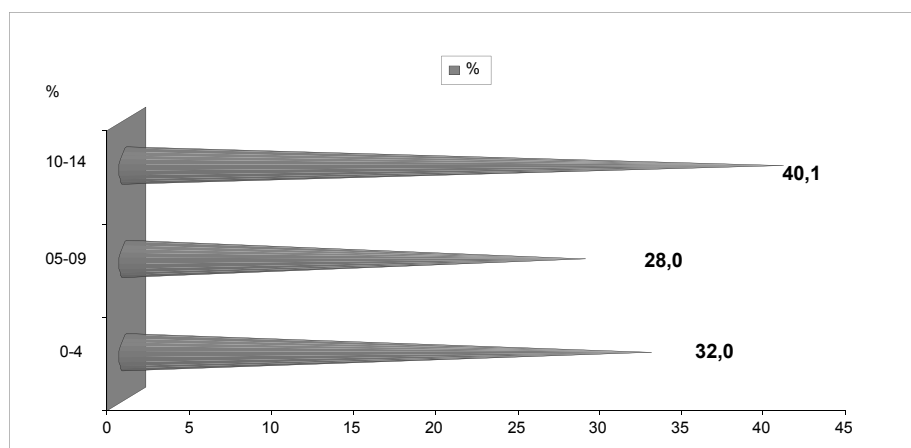
Зерттеуге Қазақстандағы 1997-2011жылдар арасындағы (15 жылдық), алғаш рет қатерлі ісік диагнозы қойылған 0-14 жас аралығындағы 4504 бала алынды. Ауру балалар жайлы мәлімет республиканың барлық онкологиялық диспансерлерінен жиналған, ҚР ДСМ мен Қазақ онкология және радиология ғылыми зерттеу институтының «Канцер-Регистрінде» тіркелген әрі сақталуда. Балалар саны жайлы мәліметтер Қазақстан мемлекеттік статистика департаментінен алынды. Мәліметтерді өңдеу санитарлық статистиканың қалыпты әдістері бойынша жүргізілді. Сырқаттанушылықтың қарқынды көрсеткіштері 100 мың балаға шағып есептелді. Сандық белгілерін сипаттау үшін қолданылған қалыпты бөлу параметрлері: орташа мәні (М), орташа квадратикалық ауытқу (σ), өсу қарқыны сырқаттанушылық бағыттары (тренді) (Т).

Нәтижелері мен олардың талқылануы

Зерттеліп отырған кезеңде республикада балалар саны 4 720 452-ден (1997) 2011жылы 3 977 878-ге азайған (742 574 балаға), бұл 15,7% құрайды. Динамикада балалар саны 2005 жылға дейін ұдайы төмендеуде болып, бұдан былай біртіндеп өсіп, 2011жылы 4,0 млн-ға жақындады, ал төмендеу қарқыны $T = -0,05\%$ құрады. Қазақстанның бүкіл тұрғындарындағы қатерлі ісік құрамындағы ауру балалардың үлес салмағы орта есеппен 1,1%, динамикасында 1997 жылғы 1,06%-дан 2011 жылы 1,12%-ға дейін және өсу қарқыны $T = 0,0011\%$ (1-сурет). Жас топтарына қарай: 00-04 жас - 32,0%; 05-09 жас - 28,0% және 10-14жас - 40,1% болып, салыстыру кезінде соңғы жас тобындағы ауру балалардың үлес салмағы жоғары екені анықталды (2-сурет). 1997-2011 жыл аралығында 0-14 жастағы балалардың қатерлі ісікпен сырқаттанушылығының орташа көрсеткіші жалпы балалардың 7,5% құрады. Динамикасында балалардың қатерлі ісікпен сырқаттанушылық көрсеткіші 2001жылғы 6,5%-дан 2011жылы 8,5%-ға өскені байқалды ($T_{\text{аб}} = 0,13\%$). Зерттеліп отырған кезеңде балалардың жалпы санының төмендеуіне қарамай, балалардың сырқаттанушылық көрсеткішінің жайлап ұдайы өсуде екені анықталды. Бұл



Сурет 1 - Қазақстандағы балалар санының 1997-2011жж. үлес салмағы және қатерлі ісіктермен сырқаттанушылығы көрсеткіштерінің динамикасы



Сурет 2 - Қазақстандағы қатерлі ісікпен ауырған балалардың жас аралығына байланысты 1997-2011жж. орташа жылдық үлес салмағы



Сурет 3 - 1999-2011жылдары Қазақстанның 00-04 жас аралығындағы балаларының қатерлі ісікпен сырқаттану динамикасы

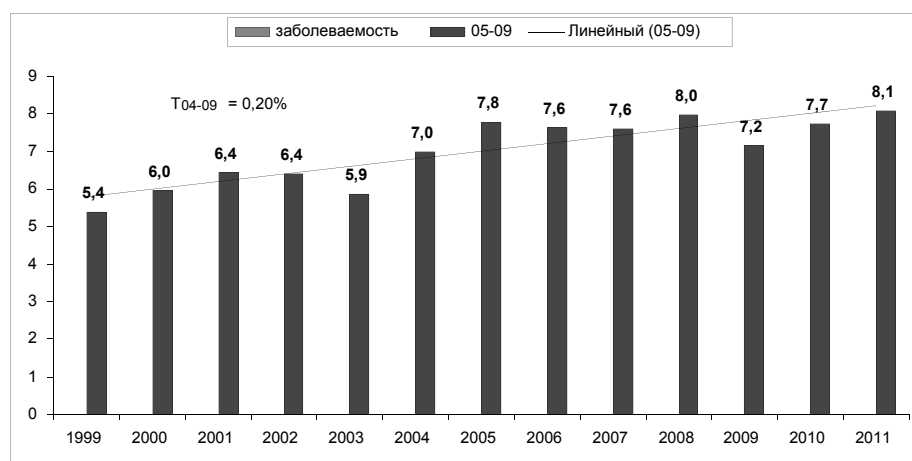
мәліметтердің негізінде, біз балалардың онкологиялық сырқаттанушылығының негізгі себебі тұрғылықты мекенінің географиялық-аймақтық ерекшелігіне байланысты жағымсыз факторлармен қатар, ауру балалардың ата-анасына әсер ететін кәсіби зияндылықтар және генетикалық факторлардан деп болжаймыз.

Еліміздегі балалардың жас аралықтары бойынша қатерлі ісікпен сырқаттану динамикасын талдағанда, 00-04 жастағы балалар арасында (3-сурет) сырқаттанушылықтың

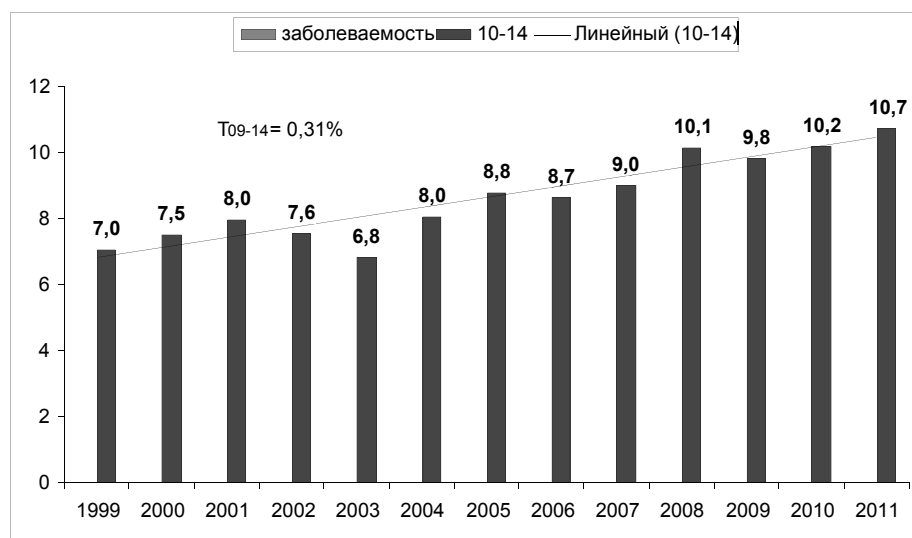
шыңы (9,2‰) 2001 жылға келетіні байқалса, кейінгі жылдары төмендей отырып 2011 жылы 7,1‰-ға түскен және сырқаттанушылық бағыты (тренді) төмендеу үрдісіне ие болған ($T_{00-04} = -0,18\%$).

Балалардың 5-9 жас арасында қатерлі ісікпен ауруы динамикасының көрсеткіші 1999 жылдан (5,4‰) бастап қарқынды ұлғайып, 2011 жылы 8,1‰-ға жеткен. Өсу қарқыны $T_{04-09} = 0,20\%$ құрады (4-сурет).

Алдыңғы топқа қарағанда республиканың келесі 10-14 жас тобындағы балаларының сырқаттанушылық



Сурет 4 - 1999-2011жылдары Қазақстанда 05-09 жастағы балалардың сырқаттанушылық динамикасы



Сурет 5 - 1999-2011жылдары Қазақстанда 10-14 жастағы балалардың сырқаттанушылық динамикасы

көрсеткішінің өсуі айқын көзге түседі. Ауру динамикасында (1999) 7,0‰-дан 2011 жылы 10,7‰-ға өскен (5-сурет). Өсу қарқыны да жоғары болған ($T_{10-14} = 0,31\%$).

анасына әсер ететін канцерогендік компоненттерімен қатар гендік факторлармен байланысты деп болжауға мүмкіндік береді.

Қазақстанда балалар арасында қатерлі ісіктердің таралуының аймақтық ерекшеліктері біздің келесі жұмыстарымызға арқау болмақ.

Қорытынды

Сонымен, 1997-2011жж аралығында Еліміздегі балалардың қатерлі ісіктермен аурушылығының көрсеткіштерін талдап, барлық тұрғындар арасында балалардағы қатерлі ісіктердің үлесі 1,1% екендігі анықталған ($T_{ув} = 0,0011\%$). Балалардың қатерлі ісіктермен сырқаттанушылық динамикасы 2001жылы 6,5%-дан 2011жылы 8,5%-ға өскені байқалды, бұл балалар санының кемуіне сай келмейді. Мұндай заңдылық Қазақстанда тұратын балалар арасында қатерлі ісіктердің пайда болуында демографиялық фактор жетекші деген тұжырым жасауға мүмкіндік бермейді. Мұны біз балалардың жекелеген топтары арасындағы қатерлі ісіктермен сырқаттанушылық көрсеткішінің динамикасын талдау барысында анықтадық. Ендеше, алынған бұл мәліметтер арқылы біз қатерлі ісіктердің таралуының ерекшеліктері Қазақстан аумағында климаттық-географиялық, әлеуметтік-экономикалық жағынан күрт ерекшеленетін аймақтардың болуынан, сыртқы ортаның жағымсыз факторларымен және өндірістік қалдықтар мен зиянды түтіндердің ауру балалардың ата-

Әдебиет тізімі

1. Себорина Т.А.. *Современные стратегии организации управления регионального здравоохранения: руководство «подходы и перспективные технологии»*. - М.: TsNII OIZ, 2003. - 344с.
2. Давыдов М.И., Аксель Е.М. *Статистика злокачественных новообразований в России и других странах СНГ в 2004 году // Вестник РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН.* - 2006.- № 3 (доп.). - С.116-117.
3. Аксель Е.М., Горбачева И.А. *Злокачественные новообразования у детей // Вестник РОНЦ им. Н.Н.Блохина.* - 2008.- №2(доп.1). - С.135-152.
4. Давыдов М.И., Аксель Е.М. *Статистика злокачественных новообразований в России и других странах СНГ в 2005 году // Вестник РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН.* - 2007.- № 2 (доп.). - С.136-139.
5. Чиссов В.И., Старинский В.В., Петрова Г.В. *Текущее состояние онкологической помощи населению России в 2007 году.* - М.: МНИОИ им. П.А. Герцена, 2008. - 184с.
6. Чиссо В.И., Старинский В.В., Петрова Г.В.. *Злокачественные*

новообразования в России в 2007 (заболеваемость и смертность). -М.: МНИОИ им. П.А. Герцена, 2009.- 244 с.

7. Дурнов Л.А., Байков К. Первичная и вторичная профилактика опухолей у детей//Врач.- 2004.-№ 11.- С.11-13.

8. Дурнов Л.А., Бондарь т.и., Валентей Л.В. Организация контроля и роль клинического прогноза в детской онкологической службы //Вестник РАМН.-2001.-№9.-С.24-27.

9 Давыдов М.И. Профилактика, ранняя диагностика и лечение злокачественных новообразований. Курс лекций в рамках подпрограммы «О некоторых мероприятий по развитию онкологической помощи населению России».- М.: Издательская ГРУППА РОНЦ, 2006.- 387с

Аннотация.

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы

Жумашев У.К., Игисинов С.И., Садыков С. С., Быковская А.Н., Тохмолдаева К.А.

Анализ заболеваемости злокачественными опухолями у детей за 1997-2011гг в Республике Казахстан

Проведен анализ показателей заболеваемости 4504 детей в возрасте от 0 до 14 лет Казахстана за 1997-2011гг. Установлено, что в структуре злокачественных опухолей всего населения доля заболеваемости детского населения составляет 1,1%, и в динамике в целом остается относительно стабильной, темп прироста тренды заболеваемости очень низкие ($T_{y,6} = 0,0011\%$). Однако, показатели заболеваемости злокачественными опухолями детского населения в динамике имеет тенденции к

росту с 6,5‰ в 2001 г. до 8,5‰ в 2011 году. Решено изучить заболеваемости злокачественными опухолями у детей в РК и обосновать основные направления совершенствования специальной помощи этим больным.

Ключевые слова: злокачественные опухоли, дети, показатель заболеваемости, Казахстан.

Summary

U.K.Zhumashev, S.I.Igisinoy, S.S.Sadykov, A.N.Bykovskaya, K.A.Tohmoldaeva

Kazakhsky National Medical University S.D. Asfendiyaro, Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology
Analysis of the incidence of malignant tumors in children from 1997 to 2011 in the Republic of Kazakhstan

The analysis of morbidity 4504 children aged 0 to 14 years of Kazakhstan for 1997 to 2011 . It is established that the structure of malignant tumors of the population share of child morbidity was 1.1 % , and in the dynamics of the whole remains relatively stable, the rate of growth trends of incidence is very low ($T_{y,6} = 0.0011\%$). However, the incidence of malignant tumors in the pediatric population dynamics have a tendency to increase from 6.5 % of the company in 2001 to 8.5 % of the company in 2011. Decided to examine the incidence of malignant tumors in children in the Republic of Kazakhstan and the main areas for improvement to justify special care to these patients .

Keywords : malignant tumors , children, incidence , Kazakhstan.